

ВИНЬЕТКИ

Ургентная гинекология

Пять вызовов: внематочная, перекрут яичника, апоплексия,
ВЗОМТ, разрыв трубы

Сначала все задачи, затем все решения. Разборы взяты из уже закрытых задач.
Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 16 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Задачи

Случай 1. Две полоски и боль

Женщина, 26 лет, вызов на дом. Тянущая боль внизу живота справа, 2 дня; сегодня утром усилилась. Скудные тёмно-коричневые выделения из влагалища 3 дня.

Задержка менструации 6 недель. Тест на беременность положительный. Год назад — лечение хламидийной инфекции. Контрацепцию не использует.

В сознании, бледновата. АД 110/70 мм рт. ст., ЧСС 88 в минуту, температура 36,6 °С, SpO₂ 99 %. Живот мягкий, болезненный в правой подвздошной области. Перитонеальных знаков нет.

1. Два наиболее вероятных диагноза? Какой нельзя пропустить?
2. Какой фактор в анамнезе повышает риск внематочной?
3. Полный алгоритм на месте.
4. Куда госпитализировать? Какой уровень? Обоснование.
5. В пути АД упало до 85/55 мм рт. ст., ЧСС 115 в минуту. Что произошло? Что меняется?

Случай 2. Общежитие

Девушка, 19 лет, общежитие. Лежит на кровати, согнувшись, стонет. Схваткообразная боль в правом нижнем отделе живота. Началась 2 часа назад, внезапно, «проснулась от боли». Тошнота, рвота 3 раза.

Менструации регулярные, последняя — 2 недели назад. Половой жизнью не живёт. Три месяца назад на УЗИ нашли кисту яичника 5 см, сказали наблюдать.

АД 120/80 мм рт. ст., ЧСС 100 в минуту, температура 37,2 °С, SpO₂ 99 %. Выраженная болезненность справа, умеренный дефанс. Перистальтика выслушивается.

1. Два наиболее вероятных диагноза? Что в анамнезе критически важно?
2. Почему аппендицит здесь менее вероятен?
3. Обезболивание — что и почему именно это?
4. Куда и как быстро госпитализировать? Почему скорость важна?
5. Подруга спрашивает: «Ей операцию будут делать? Она потеряет яичник?» Что ответить?

Случай 3. После тренировки

Женщина, 22 года, фитнес-клуб. Внезапная боль внизу живота слева во время прыжков на скакалке. Терпимая, но «как будто что-то лопнуло».

Менструации регулярные, сейчас 16-й день цикла. Половой жизнью живёт, контрацепция — презервативы. Задержки нет.

В сознании, слегка бледная. АД 105/65 мм рт. ст., ЧСС 92 в минуту, SpO₂ 99 %, температура 36,7 °С. Живот мягкий, умеренная болезненность слева в нижнем отделе. Перитонеальных знаков нет. Выделений нет.

1. Наиболее вероятный диагноз? Почему именно этот — через цикл.
2. Какой симптом может появиться через 30–60 минут, если кровотечение продолжается?
3. Алгоритм на месте.
4. Нужна ли транексамовая кислота? Обоснование.
5. На каком АД начинать волноваться?

Случай 4. Спираль и температура

Женщина, 35 лет, вызов на дом. Боль внизу живота с обеих сторон, 4 дня, нарастающая. Сегодня температура 38,3 °С. Мутные выделения из влагалища.

ВМС (медная) установлена 2 недели назад. Половой жизнью живёт, постоянный партнёр. Задержки нет.

АД 125/80 мм рт. ст., ЧСС 96 в минуту, температура 38,3 °С, SpO₂ 99 %. Живот мягкий, болезненность в нижних отделах с обеих сторон. Умеренное напряжение над лоном. Перитонеальных знаков нет.

1. Наиболее вероятный диагноз? Что в анамнезе ключевое?
2. Какой диагноз обязана исключить бригада, несмотря на отсутствие задержки?
3. Чем опасен этот диагноз в долгосрочной перспективе?
4. Алгоритм. Давать ли антибиотики на месте?
5. При каких симптомах этот вызов стал бы экстренным?

Случай 5. Кинжал и плечо

Женщина, 33 года, офис. Закричала, схватилась за живот, упала со стула. Лежит на полу, бледная, покрыта холодным потом. «Болит живот и почему-то левое плечо».

Беременность 8 недель, на учёте не стояла; утром были мажущие выделения, «думала пройдёт». Предыдущая внематочная 2 года назад, правая труба удалена.

АД 75/45 мм рт. ст., ЧСС 135 в минуту, SpO₂ 96 %, температура 36,2 °С. Живот напряжён, резко болезненный, разлитой дефанс. Из влагалища — скудные тёмные выделения. Кожа холодная, мраморная.

1. Диагноз? Три аргумента.
2. Почему болит левое плечо? Название симптома.
3. Полный алгоритм — каждый шаг, каждый препарат, каждая доза.
4. Какие три факта из анамнеза делают этот случай учебным?
5. Допустимо ли целевое АД 75/45 мм рт. ст. в данной ситуации? Обоснование через damage control.

Решения

Случай 1

1. Внематочная беременность — нельзя пропустить: задержка 6 недель, положительный тест, боль справа, мажущие выделения. Угрожающий выкидыш. Аппендицит не забывать.
2. Хламидийная инфекция в анамнезе → рубцевание труб → воспалительные заболевания органов малого таза — главная причина трубной внематочной.
3. Дыхательные пути свободны. SpO₂ 99 % — без кислорода. Монитор, вена; пока АД 110/70 мм рт. ст. — не лить, систему приготовить. Глюкометрия. Обезболивание: фентанил 50 мкг внутривенно; беременность не исключена, НПВС нельзя. Мониторинг каждые 5 минут: ЧСС — ранний маркер кровотечения.
4. Стационар 2-го уровня: гинекология и УЗИ. Пациентка стабильна, 3-й уровень не нужен. В стационаре — трансвагинальное УЗИ и β-hCG.
5. Вероятен разрыв трубы: 6 недель — как раз окно. Инфузия 500 мл кристаллоидов, damage control. Транексамовая кислота 1 г внутривенно. Кислород. Перемаршрутизация на 3-й уровень. Ноги приподнять, согревание.

Случай 2

1. Торсия яичника — перекрут ножки кисты: внезапная коликообразная боль, тошнота и рвота, известная киста 5 см. Аппендицит всегда в дифференциале. Критично: киста 5 см — рычаг для перекрута; половой жизнью не живёт — внематочная маловероятна.
2. Нет миграции боли. Боль схваткообразная, при аппендиците — постоянная, нарастающая. Выраженная рвота. Известная киста. Исключить аппендицит без визуализации нельзя — это задача стационара.
3. Половой жизнью не живёт — беременность исключена. Кеторолак 30 мг внутривенно. Дротаверин 40–80 мг внутривенно при коликообразной боли. Если недостаточно — фентанил 50 мкг.
4. Стационар 2-го уровня, лапароскопия. Быстро: окно до необратимого некроза яичника — 6–8 часов. Уже прошло 2 часа. Время равно яичнику и фертильности.
5. Не паниковать и не обещать. Объяснить, зачем спешить: УЗИ, при подтверждении — лапароскопия; если успеть, яичник раскручивают и сохраняют.

Случай 3

1. Апоплексия яичника, овуляторная. 16-й день цикла при 28-дневном — овуляция. Физическая нагрузка повышает внутрибрюшное давление и рвёт фолликул или жёлтое тело. Ощущение «что-то лопнуло» — классика. Задержки и выделений нет — внематочная маловероятна, но не исключена.
2. Симптом Куленкампа — болезненность при мягком животе: кровь уже в полости, перитонита ещё нет. При большом объёме — симптом Кера, боль в левом плече. Нарастание тахикардии — ранний признак.
3. Монитор, вена приготовить, пока не лить. АД 105/65 мм рт. ст. — пограничное. Фентанил 50 мкг: презерватив не даёт 100 % исключения беременности. Динамика каждые 5 минут, ЧСС — главный ранний маркер. Стационар 2-го уровня.
4. Пока нет. Пациентка гемодинамически стабильна. Транексам показан при активном кровотечении с гиповолемией. Если в пути ухудшение — 1 г внутривенно.

5. ЧСС >100 в минуту при текущем АД настораживает. АД <90/60 мм рт. ст. или падение САД больше 20 от исходного — damage control. Шоковый индекс ЧСС/САД >1,0 — кровотечение прогрессирует. Сейчас $92/105 = 0,88$ — на грани.

Случай 4

- 1.** Острый воспалительный процесс органов малого таза. ВМС установлена 2 недели назад — пик риска в первые 3 недели. Двусторонняя боль, постепенное начало, температура, мутные выделения.
- 2.** Внематочную беременность. ВМС не даёт 100 % защиты. Задержки может не быть. Любая боль у женщины детородного возраста — исключить внематочную.
- 3.** Рубцевание труб → внематочная беременность в будущем и трубное бесплодие. Хламидийный процесс особенно коварен: почти бессимптомно, рубцы остаются.
- 4.** Фентанил 50 мкг внутривенно — беременность не исключена. Антибиотики на месте не вводить: нужны посев и схема стационара. Исключение — сепсис с нестабильной гемодинамикой. Госпитализация на 2-й уровень: ВМС плюс воспалительный процесс — извлечение спирали и внутривенные антибиотики.
- 5.** Температура >39 °С плюс тахикардия >110 плюс гипотония — tuboовариальный абсцесс с сепсисом. Дефанс и Щёткин–Блюмберг — пельвиоперитонит. Нарушение сознания — септический шок.

Случай 5

- 1.** Разрыв маточной трубы при внематочной беременности. Геморрагический шок III степени. Аменорея 8 недель, мажущие выделения, кинжальная боль — классическая триада. АД 75/45 мм рт. ст., ЧСС 135 в минуту, мраморность — шок. Предыдущая внематочная, правая труба удалена — риск около 10 раз, осталась левая труба.
- 2.** Симптом Кера. Кровь под левым куполом диафрагмы раздражает диафрагмальную брюшину, боль идёт по диафрагмальному нерву, C3–C5, в левое плечо.
- 3.** На бок. Кислород 15 л/мин через маску с резервуаром. Две вены 16–18G. Инфузия 500 мл тёплых кристаллоидов, damage control. Транексамовая кислота 1 г внутривенно. Не лить до нормального АД. Глюкометрия, согревание. Фентанил 25–50 мкг внутривенно, осторожно при гипотензии. Стационар 3-го уровня, звонок заранее: нужен операционный стол и кровь.
- 4.** Предыдущая внематочная — сильнейший фактор риска. Правая труба уже удалена. Утром были выделения, «думала пройдёт» — типичное игнорирование предвестников.
- 5.** В рамках пермиссивной гипотензии целевое САД при геморрагическом шоке — 70–80 мм рт. ст. Сейчас САД = $45 + (75 - 45)/3 = 55$ мм рт. ст. — ниже цели, лить до 70, не выше 80–90. Высокое АД срывает тромбы. Жидкость — мост до операционной, не лечение.

Основные выводы

№	Вывод
1	Задержка, положительный тест, боль справа — внематочная, пока не доказано иное. НПВС нельзя. ЧСС падает раньше АД.
2	Киста плюс внезапная колика — перекрут. Окно 6–8 часов. Беременность исключена — кеторолак можно.
3	Середина цикла плюс «что-то лопнуло» — апоплексия. Транексам только при гиповолемии. Шоковый индекс на грани уже при 0,88.
4	ВМС первых трёх недель плюс двусторонняя боль и температура — воспалительный процесс. Внематочную всё равно исключать. Антибиотик на месте не вводить.
5	Боль в левом плече при шоке — симптом Кера, кровь под диафрагмой. САД 55 — лить до 70, не до «нормы».